需要的醫療服務，為市民創造一個更健康、更公平的社會。在深入探討主題之前，首先要肯定市長，很好的接納議員同仁過去 4 年來的質詢和要求。大家一直呼籲，臺南市要能夠追上其他五都，補助 65 歲以上長者的健保費用，終於市長有聽進去，而且從今年 7 月份開始實施這個政策，對於臺南市的老年福利來說，是一個很重要的突破，市民的反應也是相當的好。然而，市長，臺南市還有很多地方的老年人，特別是那些深受病痛折磨，剛剛提到的三管病人，因為缺乏合適的醫療設施，還在苦苦等待中，有些人甚至連床位都來不及等到，就這樣子離開了。我想生、老、病、死是每個人必須經歷的生命過程，生病是沒有辦法避免的，然而醫療體系不足以應對的時候，生病就變成一個必須要小心、謹慎對待，仔細思考的問題。在市政府一心致力於發展觀光、經濟的同時，是不是能夠撥出更多的關懷，給這些飽受病痛折磨的病患，還有備受煎熬的家屬，給予一些支持，這個是個蠻嚴肅的問題，不能忽視。我們在追求經濟發展的同時，也不可以遺忘那些急需我們伸出援手的病患和家屬，他們正處於極度的壓力與困境之中，需要臺南市政府的關心、支持。在此想要請問市長，市長，你知道我剛剛提到所謂的「三管病人」是指插著哪三種管的病人呢？

黃市長偉哲：

插管就是鼻胃管、還有……

衛生局蘇局長世斌：

我向議員說明一下，這個三管是指氣切管，鼻胃管進食，還有導尿管。另外現在比較鼓勵做胃造廔管，在胃的地方打洞，一樣是三個管路。

吳議員禹寰：

謝謝局長專業的回答，三管包括鼻胃管、尿導管還有氣切管。在長者因為疾病跟老化，失去咀嚼吞嚥功能時，就需要插鼻胃管來協助進食；失去排泄能力時，就需要導尿管。這兩個管路同時存在於病人體內的時，稱之為兩管病人，然後再接上氣切管時，就變成所謂的三管病人。就兩管病人而言，他們的症狀對於三管病人來說比較輕微，照顧上相對稍微簡單一點，一般的養護機構都可以提供收容。然而三管病人的情況就比較複雜，氣切管要透過將喉部切開傷口來放置，需要特別照顧傷口以避免感染，所以在更換三管的時候，需要由更專業的醫護人員來處理。除了可以在醫療院所進行照顧之外，具備專業醫護團隊的護理之家，好像也可以提供收容服務。另外，如果家裡有購置一些呼吸設備的話，就可以在居家的環境下來進行照顧。然而，目前廣布於各行政區的長照中心，好像沒有能力來接收三管病人。局長，目前臺南市的長照中心是不是有能力接收三管病人？如果沒有，市政府有沒有相應的計畫或措施，建立能夠收容三管病人的照護機制？

衛生局蘇局長世斌：

容我向議員做比較完整的說明。今天我們討論的議題，是醫療體系銜接長期照護體系的問題，所謂三管病人一般都是重症、長期失能，比較沒有需要急性的醫療照顧，需要的是長期照護。一般會經由醫院的出院準備委員會，在出院的時候，醫院的護理師會安排，適合住到怎麼樣的機構，或者是在家裡照顧，在家照顧需要什麼樣的設備跟指導，這些會透過出院準備委員會來說明、轉介。臺南市 35 家醫院都設有出院準備的服務，轉介出去之後，如果是比較重症的，三管病人屬比較重症需要長期照顧，一般來講，大概

就是轉介到護理之家，臺南市目前登記在案的有 76 所護理之家，由衛生局主管，76 所大概可以提供 6,300 個床位左右，通通都可以收置服務三管病人。

吳議員禹寰：

有 6,000 多床嗎？

衛生局蘇局長世斌：

在護理之家有 6,000 多床，假如家裡的照顧能力足夠，我們也會鼓勵在家裡照顧。我個人長期從事居家護理的工作，也會到住家去幫居家的病人做換管路的服務，實際上有很多家庭能力好的，也可以照顧的相當好。目前大概就是有護理之家可以照顧，其他的長期照護中心，有的也可以來照顧這樣比較重症，需要長照的病人。

吳議員禹寰：

好，我在這邊向局長匯報一個蠻令人擔心的狀況。這是 3 個多月前的事情，當時有民眾向我反映，家中的長輩因為身上插著 3 個管子，需要住院安置，當時這些家屬嘗試聯絡其他醫療院所，希望將長輩轉院，但是發現所有的醫院都客滿。即使是排隊等待，每家醫院的等候名單，至少都有幾 10 個人排在前面，有些家屬的號碼甚至都已經排到將近百號這麼多。他們很焦急的四處奔走，想盡辦法為長輩尋找病床，但是一直找不到可以供其安置的床位。或許是如同坊間的傳聞，受限於健保法規的規定，聽說醫院只能提供 1 個月的住院期限，期滿後病人必須要遷出。雖然健保署做了很多次澄清，修法過，並沒有這相關 28 天的規定，但是臺南市大醫院一位難求的狀況，也加劇了醫院要求病患住院期間儘量縮短的潛規則。身為民意代表，非常希望能夠幫助這些家屬解決困難。每個醫院提供的三管病人床位，似乎都受到額度的限制，就像 1 個蘿蔔 1 個坑的局面，很難再找到額外的病床來供應。局長，關於臺南市醫療系統的重要問題，涉及三管病人床位的供應情況，我想請問，臺南市醫療系統到底有多少床位可以提供給這些三管病人？

衛生局蘇局長世斌：

向議員報告，醫療系統指的是醫院，醫院沒有三管的問題，醫院本來就是在收容、收置急重症的病人，比如有泌尿道感染、肺炎這些問題，治療好了之後，後面就是所謂照護的問題。長期照護分為重度照護或者是輕度照護，三管屬於比較重度的照護，一般會經由剛才所提到的出院準備委員會護理師，協助安排轉介到照護機構。

吳議員禹寰：

局長，依你目前了解，有多少需要住院照護的三管病人，找不到可供入住的床位？你手上有掌握住大概的資料嗎？

衛生局蘇局長世斌：

這個沒有辦法掌握到。

吳議員禹寰：

沒有辦法掌握到在等待床位的病人。好，三管病人就像局長說的，需要特殊照顧跟治療，他們的床位需求是急迫而且重要的，我們要正視現實，是否存在供需失衡的一個狀況。如果大量的三管病人找不到床位入住的話，就代表在床位的供應方面，存在嚴重不足的情況。根據衛福部醫事管理系統的資料，臺南市目前總計有 460 床的呼吸照顧病床，其中包括 388 床一般呼吸照顧病床，跟 72 床亞急性呼吸照顧病床。在此我想要請問

衛生局長，這個數字是否已經納入臺南市5家護理之家，所提供的20床三管病人照顧病床？

衛生局蘇局長世斌：

向議員報告，這個就是所謂的「RCW 亞急性呼吸照顧病床」，是提供給醫院裡需要使用呼吸器的病人，當病人呼吸衰竭，在醫院使用呼吸器，經由很努力的嘗試脫離，如果沒有辦法脫離的時候，就變成呼吸器依賴，即所謂的RCW呼吸照護病床。在醫院裡面，剛剛所提到的460床就是所謂的呼吸照護病床，這個是要在醫院，不會在護理之家，也不會設在所謂的長照中心，大概是這樣。

吳議員禹寰：

好，我在這邊考慮到，臺南市有180萬的人口，並且作為6個直轄市之一，必須要去反思，僅有的幾百張病床，是不是夠滿足目前三管病人的需求？面對這種挑戰，需要深入的思考，再來找出一些解決的方案。局長，你認為這400多床夠用嗎？

衛生局蘇局長世斌：

呼吸照護病床目前是夠用，而且目前健保或者是臺灣醫療趨勢，是在慢慢減少所謂的無效醫療，希望能夠提供照顧品質、生活品質。很多病人使用呼吸器可能5年、10年了，生活品質是很不好的，所以我們現在推動所謂的DNR(不施行心肺復甦術)，就是其中一個；第二個就是三管的部分，三管其實很穩定，是可以在家裡照顧的，就是要更換氣切管、鼻胃管、導尿管，這部分居家護理所……

吳議員禹寰：

局長，你剛剛竟然說覺得病床數都已經足夠了，可能因為局長你才剛上任，還沒接到太多需要病床的關心服務案件，我是每天在接，所以你剛才說的真不適合我聽。

衛生局蘇局長世斌：

剛剛議員說的跟我說的不一樣，三管跟呼吸照護是不一樣的。

吳議員禹寰：

對，也是相同的意思，都缺病床。

衛生局蘇局長世斌：

是不一樣的病人。

吳議員禹寰：

好，再來，在評估病患病情後，醫院會判定三管病人是不是需要住院，就像局長所說的，實際上一旦病患需要氣切的時候，通常就是病情真的已經很嚴重了。對於一般家庭來說，自行照顧三管病人很不容易。首先，我們要照顧呼吸障礙三管病人，必須要自備一套，同時具備吐、吸雙向功能的呼吸器，這套設施的費用通常在10萬到15萬元之間。另外，病患還需要自行負擔管路的更換，這些耗材的費用，通常一般材質的管路大概要兩週換1次；如果是矽膠材質的話，大概至少1個月更換1次。病患可以自己選擇到醫院來進行更換，或者是申請居家護理師提供到府的服務。我想請問，相關管路更換的費用，是由市政府提供免費服務，還是個人支付？如果是市政府支付的話，每次的費用大概是多少？

衛生局蘇局長世斌：

向議員報告，符合這樣條件的病人，基本上都是重大傷病；重大傷病在健保裡面是完全免部分負擔。所以需要做管路照護服務的話，居家護理師會到住家去更換，如果住在護理之家的話，也有護理之家的護理師會更換，完全不用錢，由全民健保來支付。

吳議員禹寰：

我在這邊再請教局長，臺南市有多少三管病人已經申請居家護理師到府更換管路的服務，大概有多少病人？

衛生局蘇局長世斌：

這部分我稍微查過，健保目前是沒有這樣的統計數據，不過據我了解，估計大概在5,000、6,000人吧。

吳議員禹寰：

大概5,000、6,000人。好，在這邊建議局長，後續一些相關服務的資料，會後提供給本席。對於三管病人來說，如果更換管路後沒有妥善的照顧，很容易引發感染併發症，對家屬來說，其實就是增加在家照顧的難度。三管病人的照顧並不是一件很容易的事情，除了相關費用支出外，還需要專人全天候照料，對一般家庭其實是蠻大的壓力負擔。因此，當家中有三管病人的時候，大多數家庭會傾向於住院提供照顧，然而各醫院提供的呼吸病床數量有限，許多三管病人擠破頭也沒有辦法入住，只能登記排隊等待。我們繼續談談剛才提到的家屬陳情案件，老人家在醫院住了將近1個月，醫院一直催促家屬要趕快辦出院，然而家屬找不到其他醫院可以轉院，附近的長照中心也沒有辦法提供照顧服務，只能在醫院登記排隊等待。但排隊的號碼竟然排到了77號，這讓家屬也是非常的悲痛，他們說，就算等上1年也沒有辦法等到病床。家屬就像熱鍋上的螞蟻，相當焦慮，所以來我的服務處求助，但是當時真的所有醫院都是客滿的，也只能請他們耐心的等待。後來沒有過多久，這位老人家也不幸離世了。這件事充分反映出，許多病患苦苦等待呼吸照護病床，但是還沒有等到病床，卻是先等到死亡的來臨。局長，局裡面有沒有接過類似的陳情案件？

衛生局蘇局長世斌：

我們一直都有收到。剛才議員所反映的，是在等護理之家的床位，不是醫院的病床。護理之家的床位需求，一直都是蠻高的，除了護理之家之外，現在部分歸屬在社會局的住宿型長照機構，有一些也是可以來照顧這樣的病人。臺南市目前有37家的居家護理所，大概有幾百個護理師會到住家去，或者是到長照型機構、護理之家，去做三管的管路更換服務，這不是住院。

吳議員禹寰：

這算居家照顧嗎？

衛生局蘇局長世斌：

這是長期照護的床位，不是住院。

吳議員禹寰：

好，但也是希望局裡面可以再更加重視這個問題，這是蠻多民眾很關心的一項議題，尤其是一些家中長者有這方面需求的時候，會更關切這些問題，這種案例令人深感擔憂。我們必須要關注那些等待呼吸病床的病患，還有他們面臨的這些無奈困境。臺南市這樣的大城市裡面，僅有數百個這種呼吸病床讓他們使用，這樣的數量我覺得還不夠，請局

長再深思一下，局長先請坐。市長，作為臺南市的大家長跟父母官，肩負著重要的責任、使命，然而剛剛的案例，因為三管照護醫療的缺乏而苦不堪言，甚至在排隊等待病床過程中，即使死亡臨近，都無法住院接受治療。面對這樣的現象，您有沒有什麼感想？

黃市長偉哲：

謝謝，有兩件事情向議員報告。首先，三管病人有一些是急性有一些是慢性，慢性的話，就可能需要在護理之家長期臥床；急性的話，如果有恢復的可能，或是有恢復的跡象，就在醫院裡面的急性病房。還有，一般三管病人，很多的是年紀比較大，這我們不否認。另外，成大醫院現在計畫籌設老人醫院，將來提供出來的病床，一定有一部分是給三管病人裡面的急性病床。另外，慢性的部分，我們也希望一些醫院有附設護理之家，如果再增加病床的話，一定可以收容一部分的三管病人。

吳議員禹寰：

好，謝謝市長。我想這不僅僅是一個陳情案，這是代表許多市民的心聲還有苦衷，等待過程中，渴望能夠得到適當的醫療照顧，但現實讓他們沒有辦法去實現這個願望。市長，你擁有影響力和資源，期待你能夠積極解決這些問題，以實質的解決方案和行動，未來提供更多的病床和醫療資源，滿足這些三管病患；對他們的照顧，是迫切的需求。不僅是對於三管病人的部分，實際上，臺南市一般病床的供應，也是非常短缺。這個問題無論對於市長或者民意代表來說，都是一個蠻深刻的議題。所以我們常常面臨民眾訴求「喬病床(臺語)」的狀況，民意代表能做的，也是向醫院了解目前排隊的情形之後，請院方儘量安撫這些家屬的焦急情緒，請求院方儘快提高行政效率。曾經跑過醫院的人就會常看到，急診區都擠滿等待入住病房的病患，有時候等待長達數天，凸顯臺南市醫療資源真的是嚴重不足。這種現象其實我蠻無法理解，尤其是臺南市還存在一間閒置的大型醫院，現在只是用來養蚊子。衛生局局長，我想了解目前位於臺南市大同路的空軍814 醫院，現況是怎麼樣？是不是有被用在醫療的用途？此外，我也想知道，當初興建這座醫院大概耗費了多少錢？

衛生局蘇局長世斌：

向議員報告，這個地方現在不是醫院，它是在民國 90 年，我記得是在 92 年，當時由國防部所興建的。因為是由軍方所建，所以到底花了多少錢我們不清楚，當時是空軍醫院。

吳議員禹寰：

我在這邊跟局長報告，臺南市空軍 814 醫院，其實蠻具有豐富的歷史背景。根據記載，這座醫院於民國 72 年，從中西區民生路遷移過去的。臺南府城是臺灣最早與西方文化接觸的地方之一，許多西方文化的元素，譬如基督教、西方音樂、西方醫學等等，都是從臺南擴散出去的。醫院作為社會基本設施的一環，也與臺南 400 有關，事實上，臺灣的西醫最早是在臺南出現。

衛生局蘇局長世斌：

新樓醫院。

吳議員禹寰：

對，回顧歷史，荷蘭人統治臺灣的時期從 1624 年到 1662 年，根據熱蘭遮城日記的記載，當時就已經有醫院也有醫師駐紮在裡面。於日本殖民時期的初期，臺南安平地區

曾經爆發鼠疫，就是老鼠引起的疫情，為了因應這個威脅，日本臺灣總督府選擇在市區偏僻的地方，設立了當時稱為「避病院」的機構，選中了位於安平，就是臺南與安平之間，被水環繞的清朝鎮海營砲壘，將其中一個改為收容傳染病患的醫院；那個時候的名稱叫做「避病」，就是要避開這個病，避病院之後改名為濟生醫院。文化局局長，濟生醫院2021年被指定為歷史建物到現在2年了，有相關的修復計畫嗎？

文化局謝局長仕淵：

這部分我可能再來了解，了解之後再向議員報告。

吳議員禹寰：

沒有關係，請局長之後給我一個報告。在SARS期間，原本國軍814醫院曾經投入將近1億元，增設70多間的負壓隔離病房以應當時的需求，然而現今看到相關的儀器設備都已經搬走，剩下空空的房間。這個醫院就在我的服務處附近，其實在地方上都說它像蚊子館一樣，而且病房空調是不是還能夠正常運作？經過數10年的閒置，是不是還能使用？在當地都提出蠻多的疑問。

至於剛剛講到濟生醫院的部分，我希望不要只是把它當廢墟，大筆預算在大肆慶祝臺南400的歷史，市中心的歷史建築卻好像當作廢墟在處理，會讓市民的觀感不好。文化局局長，先請坐。隨著時間的推移，從民國38年政府遷來臺灣的時候，軍方向臺南市政府商借了位於安平路的濟生醫院，這個醫院本來是上海空軍醫院，結果遷移後更名為臺南空軍醫院，就是我剛剛提到的70年6月份的時候，當時軍方取得位於生產路與大同路附近，靠近臺南機場的土地，興建了一個醫療大樓，這個醫療大樓於1983年9月完工，遷入使用後，更名為國軍814醫院，就是我剛剛所說的蚊子館，鄰近臺南機場附近，方便運送病患。身為議員，我覺得對於原國軍814醫院的現況感到蠻遺憾的，因為其實它占地蠻大的，而且在SARS期間，這座醫院曾經被規劃作為專責醫院，但是隨著疫情的退燒，就轉型變成感染症訓練中心，平日作為教育訓練場所，提供疾病管制局第四分局作為辦公處。

這座醫院曾經耗費巨資來興建，原本是為了提供重要的醫療服務，最後卻淪為辦公用的一個行政中心。當我們看到臺南市醫療資源非常匱乏的時候，很多病患沒有辦法等到病床的情況下，甚至急需呼吸儀器的三管病人都等不到病床，這樣的對比，其實我是覺得滿諷刺的。市長，我剛剛花了相當長的時間，向你陳述了沒有人關注的三管病人，還有臺南市的病患一床難求的問題，這病患其實也同樣是您的市民，我希望能夠聽聽您對這些困境的感想，以及一些解決的方法。

黃市長偉哲：

從吳議員你之前提到了三管病人現在缺乏病床，後面提到了空軍814醫院，應該是國軍814醫院，從1983年到現在2023已經40年了，它的沿革您介紹的非常清楚。目前為止，它雖是疾管署的傳染性疾病防治中心，但如果硬體建築還在，而且疾管署未全部使用裡面的廳舍，表示有閒置的廳舍。雖然已經把內部醫療設施拿掉了，但可不可能利用它的硬體設施，來作為一些慢性病床使用，我們願意研究看看，謝謝議員你提出的看法。

吳議員禹寰：

這可能就需要市長和臺南市所有的立委共同來努力，看是不是跟國防部來溝通協調。

黃市長偉哲：

如果有閒置的營舍，我們來……譬如我去行政院開院會時，去找衛福部部長討論這個部分。

吳議員禹寰：

對，因為此處曾經也是一個大型醫院，所以我相信裡面不管是線路還是管路，都是以醫療使用為優先規劃的建築，所以在硬體設備的部分，我相信相對於新蓋一間醫院來得更快，而且更有用。4 年前我首次當議員的時候，就在市政總質詢提出南關線醫療不足的問題，當時我要求市政府在沙崙高鐵特區，興建臺南市第 3 座市立醫院，以改善整個地區民眾的醫療需求，市長當時表示這個計畫可行。一經曝光後，成大醫院及奇美醫院相互表示願意接手該計畫。然而，中央政府得知這個消息，就決定介入主導，由臺南市提供土地，中央負責經費，成大醫院負責經營。這個計畫其實已經確定了，但要經過細部規劃、興建乃至營運，至少需要好幾年的時間，無法解決目前臺南市醫療資源嚴重不足的燃眉之急。所以就是剛才我所提出的，在原國軍 814 醫院，已經是蠻完善的建築物，所缺的只是軟體層面的醫療資源，剛才也感謝市長，願意去跟衛福部進行溝通，跟國防部那邊談談看。硬體已經有了，現在如果有閒置空間，就將其更擴大，在沙崙醫院成立之前，至少有一個地方可以先解決燃眉之急。感謝市長對這個提議的重視，未來希望能夠有好的結果，另外……

黃市長偉哲：

我們一定會去極力爭取。

吳議員禹寰：

謝謝市長。生病並非老年人的專屬經歷，這個世界上不存在能免於疾病的人，大部分的人都難以避免歷經疾病的考驗，特別是在當今極端氣候和不完全安全的環境下，更容易受到疾病感染，加劇醫院病床數量一直不足的問題。在迫切需要醫療服務的情況下，歸屬軍方所有的醫療機構國軍 814 醫院，閒置不用，我覺得蠻暴殄天物，是一個蠻大的浪費。希望中央、立委還有軍方來做協調，能夠早日恢復營運，解決臺南市的醫療問題。請衛生局持續給予本席這個案子的相關回饋，要繼續提供我相關的資料，局長，先請坐。現在我們要談的這個議題稍微特別一點，市長，請問你知道「鳥盡弓藏」這 4 個字是什麼意思？

黃市長偉哲：

「鳥盡弓藏」跟「兔死狗烹」一樣。

吳議員禹寰：

都是一樣，就是鳥已經打完了，弓沒有價值，就收藏起來了；比喻事成之後，有功之人卻遭到殺戮或者是疏遠的命運。市長，接下來這張照片，你記得是在哪裡拍的嗎？

黃市長偉哲：

在沙崙。

吳議員禹寰：

好，這是一張是對本席選區相當重要的照片，拍攝於 2022 年 3 月 26 日。前行政院長蘇貞昌視察臺南沙崙醫療創新園區預定地，而且正式啟動該建設的盛大時刻。這張照片說實在的，真的是熱鬧非凡；你看第一排中間偏左邊，有前行政院長、市長、成大校長以及立委王定宇，然而院長的左邊也就是行政院秘書長李孟諺；第二排中間的地方，連當時立委所支持的市議員參選人，也都站在了 C 位上。但是市長，我就不了解了，為什麼沒有邀請一直以來，有在關心、爭取這個案子的議員，沒有半個出席，沒有讓他們可以到場，向中央以及成大院方代表提出建議、建言的機會。我覺得蠻困惑與不滿，市長，為什麼中央接手後，就不需要在乎地方的聲音？

黃市長偉哲：

向議員報告，那是中央安排的，所以我到現場，事實上只是受邀。

吳議員禹寰：

受邀的嗎？在醫院建設的啟動儀式上，沒有邀請一直以來關心此案，並且提出爭取的議員出席，不禁讓人對這個建設，未來會不會充分接納地方代表的良性建議、建言，產生蠻大的疑慮。前行政院長蘇貞昌視察沙崙創新園區預定地的幾個月前，準確的說，就在 2021 年的最後一天，12 月 31 日，行政院正式核定的「國立成功大學沙崙醫療服務與創新園區先導計畫」被列為國家的重大建設。接著 2022 年的元旦，市長在隔天發了新聞稿表示，成大將於沙崙成立醫院，而醫療服務創新園區，不僅將大幅提升新豐區的醫療服務能力到達 160%，同時也將成為臺灣首例，以醫療創新、服務創新以及生醫產業為核心的科學園區。對臺南市政府、成大、新豐區甚至所有的市民來說，這無疑是最棒的新年禮物，市長也特別感謝前行政院長蘇貞昌和李孟諺秘書長協調各部會，以及賴清德副總統和立委王定宇的全力協助，讓臺南市成為世界的關鍵力量。市長，你好像覺得只有中央在協助這件事情而已，地方議員的努力，你完全沒有放在眼裡嗎？是不是對市長來說，議員就只是個市民，不需要代表選民來建言、監督，就是要我們乖乖閉嘴，收下這個禮物就好。

黃市長偉哲：

不是這個樣子的，謝謝議員。我記得所有市政府辦的活動，對於地方議員的邀請都是不遺餘力的，這點在新聞稿部分有所疏漏。尤其你剛剛提到，在最早的時候，你就已經在市政總質詢提到，新豐區需要一個醫院；這部分新聞稿沒有特別提到，抱歉，不好意思。

吳議員禹寰：

好，其實你們去視察的時候，我完全不知道，是本席的支持者看到了當初的活動，才來問我。在那時候，新豐區的 5 位議員，竟然沒有半個人知道。其實我也是覺得蠻訝異的，我不知道為什麼中央對於地方這麼的輕視，當本席的支持者看到黃市長表達的感謝詞，其實都蠻替我抱不平的，覺得市長怎麼過河拆橋。因為這件事情是本席在當選臺南市第 3 屆市議員後，第 1 次市政總質詢開始爭取的，也是在這一年，讓這個案子開始被中央關注。當時我在議事廳，以南關線也就是新豐區的龍崎、關廟、歸仁、仁德等等偏鄉地區，醫療長期不足的議題來質詢市長，指責市政府當時對此漠不關心，要求市長在高鐵特定區推動沙崙醫療專用區，充分利用當地的交通便利性，還有與北高雄接壤的一個地理優勢，當時是要求在那裡興建第 3 座臺南市立醫院，市長你那時的回應也是說

可行。質詢內容一經新聞曝光，媒體也跟進報導，成大醫院及奇美醫院都表達了與市府合作，欲接手的意願。市長，我請問你一個問題，在 2019 年 5 月 1 日的議事廳上，我曾提出南關線常年缺乏醫療資源的問題，過去市政府通常以行動醫療的方式來解決。在這之前，市政府或者是臺南市的中央民代，有沒有提出在高鐵特區興建醫院的提案或規劃呢？如果有的話，可以告訴我具體的內容跟時間嗎？

黃市長偉哲：

謝謝吳議員，有關你的提問，我的記憶所及，目前為止是沒有的。這個部分的確是中央跟地方協調好的事情，不過您剛剛提到，對於地方議員的尊重，我們絕對會再加強。

吳議員禹寰：

回顧市長在 2019 年 5 月 1 日，在議事廳對本席的回答，如果當時市政府或者是中央民代就已經提出相關的提案，市長當時應該就會說明了。現在重新檢視當時市長的回答，從頭到尾，你都肯定本席的質詢，而且認同在高鐵特區興建沙崙醫院的必要性。這項建設不僅能夠舒緩南關線沿線的行政區，包括龍崎、歸仁、關廟還有仁德區民眾對於醫療的需求，甚至還可以延伸到東區、永康區、北高雄的民眾，使其能方便就醫；同時也可以解決奇美以及成大這兩座醫院，超負荷運轉的困境。

在本席質詢期間，市長公開承諾，推動高鐵特區，建立臺南市的第 3 座市立醫院。然而，隨後市政府的行政作業，向中央爭取經費的進展階段，本席都是被動的收到相關訊息。即使該計畫已經被行政院列為國家重大建設案，前行政院長蘇貞昌也特地親自來考察了，本席仍然是透過媒體才得知這些資訊。很令人遺憾的是，市長對外的致謝內容中，只有對中央長官，還有中央民代的協助表示非常感謝；沒有提及本席以及其他議員，這些促使案的推動者。本席周遭的支持者感覺到不平，形容市長的新聞稿像「船過水無痕」一樣，市長，無黨籍的本席，作為該計畫的原始推動者，在市政府的相關決策過程中，是不是被刻意遺漏，或者是被排除在外？市長在感謝稿中，未提及地方民代對該計畫的貢獻，是不是也有意圖忽略，或者是遺忘的情況呢？

黃市長偉哲：

謝謝議員，我想應該沒有這樣的情形，不過我必須承認這是市府團隊作業的時候沒有顧及到，這是一個疏失，而且是單一事件。你可以看到，你爭取的案子和關注的事情，在地方政府的層次，都有一直跟你保持聯繫。

吳議員禹寰：

我也是很肯定黃市長及市政府的努力。

黃市長偉哲：

還有向議員報告，您提到了 814 醫院，如果有好消息，第一個會跟你報告，也特別感謝你的關心。

吳議員禹寰：

謝謝市長，剛才講了那麼多，的確病床一床難求，希望原國軍 814 醫院的空間，能有效再利用，不要讓其一直閒置下去。本席堅信，凡走過一定會留下痕跡，特別是對於地方民眾的需求，以及我為他們爭取建設、福利的努力；證據會說話，根本就不需要搶功勞或收割成果。本席這 1 年多來，並沒有以此向市長還有市府官員抱怨，這次提及此案，除了向本席周遭關心此案的支持者交代，更重要的是，在 2022 年 3 月 26 日蘇院長

在沙崙創新園區預定地視查的時候，宣布該工程已經正式啟動，第一期工程預計最快是2022年下半年動工，然而現在已經是2023年的年中了。2022年已經結束，2023年的上半年度再10幾天就過去了，沒有受邀參加啟動典禮的我，想問問看有去參加啟動典禮的市長，成大沙崙醫院的第一期工程已經動工了嗎？

黃市長偉哲：

這個部分因為是中央管制的關係，還沒有動工，應該是還沒有吧。

吳議員禹寰：

還沒有嘛!應該是要跟市政府報告，有沒有動工市長必須第一個知道，這個是臺南市……

黃市長偉哲：

如果有動工通知，我們一定會知道，雖然是中央的工程，中央在評審管制。

吳議員禹寰：

地是我們的，所以也是要尊重我們，不管怎樣，地是臺南市政府的，中央要尊重地方。

黃市長偉哲：

地方的民代我們一定會負責通知，議員以後要站在C位。

吳議員禹寰：

沒有，我隨便站，我只是覺得不要刻意去做一個政治操作而已。細節部分，衛生局局長，你知道動工了嗎？

衛生局蘇局長世斌：

向議員報告，最後版本的修正計畫，在5月1日已經送到衛福部。最近這個計畫全部核定之後，向醫院方面詢問，表示今年下半年就會啟動，開始要設計。

吳議員禹寰：

今年下半年會啟動，能不能提供明確的時間表，確保計畫按時推進，民眾的醫療需求能夠儘早得到滿足，局長覺得可以嗎？

衛生局蘇局長世斌：

因為主動權在成大醫院，所以會跟成大醫院保持密切的接觸，我們會追蹤進度。

吳議員禹寰：

一般民眾需要知道這個計畫的期程表，請會後公文提供給本席。

衛生局蘇局長世斌：

相關的訊息會提早跟外界報告。

吳議員禹寰：

好，謝謝局長，請坐。市長，本席要提醒你的是，你已經沒有連任的壓力了，只剩下3年半的任期，所以必須要更加積極推動這個工程的進度，趕在你的任期結束之前，有辦法見到這個醫院的正式營運，成為你一個非常大的政績。市長，目前你是否有制定具體的計畫，以確保成大沙崙醫院的工程在你的任期內來完成？

黃市長偉哲：